Rut: 14.278.557-9
FN: 14/09/1976
HC: 20001522 91

Dg: Tetraparesia en estudio
VIH +
15:00

HOSPITAL CLÍNICO HDA. MARTÍN
Terminal Estadístico Medicina - UCI - TIM
Módulo E

SAMU 131

Hospital Clínico Herminda Martín Chillán Nivel

143-0299

SOLICITUD AMBULANCIA

FONASA

Nombre Paciente: Marcelo Sepulveda Sepulveda

Edad: 51 años

Cuenta Corriente: 8793831231

RIESGO DE CAIDAS
- [ ] Alto
- [x] Medio
- [ ] Bajo

Centro Responsabilidad/Sala/Cama: Medicina 1B-9

Destino: Hospital San Carlos

Motivo: Traslado

Fecha: 16/12/24

Hora:

DOCUMENTOS
- [ ] Ficha Clinica
- [x] Resumen Médico
- [x] Epicrisis Enfermeria
- [ ] Interconsulta

Teléfono de Contacto del Centro Receptor: 426674

Responsable:

REQUERIMENTOS DEL PACIENTE

- [ ] Oxigeno
- [x] Camilla
- [x] Móvil Básico
- [ ] Móvil Avanzado
- [ ] Incubadora
- [ ] Bombas de Infusión
- [ ] Aspiración
- [ ] Ventilación Asistida
- [ ] Vía Venosa Preiférica
- [ ] Vía Venosa Central
- [ ] Monitorización
- [ ] Acompañante
- [ ] Otros _____

CONDICIÓN DEL PACIENTE

CATEGORIZACIÓN A [ ] B [ ] C [x] D [ ]

PREVISIÓN Y V°B° SOME: A [ ] B [ ] C [ ] D [ ] Particular [x] Isapre [ ]

RECEPCIÓN EN SAMU Hora _____ Fecha _____

HOSPITAL CLÍNICO HERMINDA MARTÍN DE CHILLÁN
CENTRO RESPONSABILIDAD MEDICINA

Dra. Salgado López
Neróloga
26.707.190-4

NOMBRE Y FIRMA MEDICO TRATANTE

EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL HERMINDA MARTIN	Nº EGRESO	: 100530
SERVICIO	: MEDICINA HHM	HC	: 2000152291
FECHA	: 16-12-2024	CTA. CTE.	: 869118391
		CP.	: 276330

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	:MARCELO NARCISO SEPULVEDA SEPULVEDA			RUN	:14.278.557-9
F.Nac	:14-07-1973	Edad	:51 AÑOS, 5 MESES	Género	:Masculino
Dirección	:P. DEL SOL ELOY PARRA 0279			Comuna	:SAN CARLOS
Previsión	:FONASA B	Teléfono	:73369514		
Fecha Ingreso	:2024-11-19	Fecha Egreso	:16-12-2024	Causal	:MEDICA
Condición	:VIVO	Destino	:DERIVACIÓN OTRO ESTABLECIMIENTO EN RED	Derivación	:TRASLADO OTRO HOSPITAL

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. O98.7-ENFERMEDAD POR EL VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA(VIH) QUE CO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- Tetraparesia en estudio
--> Polineuropatía sensitivo motor + miopatía proximal
- VIH-SIDA
- Neumonia por aspergillus fumigatus
- PNA izquierda por E. faecalis resistene a vancomicina TRATADA
- ERC ETAPA 4 SINDROME NEFRÓTICO SECUNDARIO
- COLONIZACIÓN URINARIA POR P AEURIGINOSA BLEE
- HTA
- DM2 IR
- ICC FEVI 25%
- IAM previo con Enf severa de 3 vasos (junio 2024):
--> PTCA de ADAm y ADAp.
--> ACx 70% - ACd 70%

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. G62-OTRAS POLINEUROPATIAS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. G62-OTRAS POLINEUROPATIAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. B20.5-ENFERMEDAD POR VIH, RESULTANTE EN OTRAS MICOSIS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. N18.4-ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ESTADIO 4 (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. E10-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino de 51 años con antecedentes descritos, con cuadro larvado de debilidad de extremidades inferiores asociado a dolores musculares generalizados y diarrea, evoluciona con imposibilidad de caminar por lo que no retira remedios y se mantiene sin TARV por 1 mes aprox. Evoluciona con dolor abdominal, nauseas y vomitos por lo que consulta el 24/09 en HSC donde se diagnostica CAD, la cual tras su resolución pide alta voluntaria. Reingresa a los 3 días por mayor compromiso motor de las 4 EE asociado a mialgias, destaca AKI KDIGO III, TAC TAP con focos de neumonia bilateral y signos de PNA izquierda con multiples microabscesos. Tratado inicialmente con tazonam y cotrimoxazol, se realiza LBA que descarta TBC, cultivo (+) Aspergillus fumigatus, UC (+) E. faecalis resistente a vancomicina, en tratamiento con voriconazol y linezolid por 19 días que luego se rota a ampicilina, con TAC de control del 21/10 que muestra aun signos de pielonefritis I° con 2 pequeñas colecciones. En cuanto a la tetraparesia se descrta Sd Guillain-Barre, CK total 27.000, EMG informa signos de PNP de fibra gruesa, aguda sensitivo- motora simétrica con daño axonal y desmielinización asociada. Signos de miopatía de predominio proximal con signos irritativos en actividad de inserción y reposo sugerente de proceso agudo. Para completar estudio se toma perfil inmunológico: ANA + 1/80 patron huso mitotico (AC-25), ANCA P + (sin titulo), pero con MPO y PR3 negativos, Anti DNA -. Panel de miositis: Ro 52 15, PL-12: 12 (positivos de 11-50. >50 positvo fuerte). Otros: Virus EB -, CMV IgM 1.7 (positivo > 1.1) IgG 36 (positvo > 10).
Se traslada a HCHM para continuar estudio y evaluación por especialistas. Evaluado por reumato y se descarta vasculitis, visto por infecto se continua tratamiento con voriconazol con TAC de control con mejoría evidente por lo que se indica completar 56 días de trtamiento, usuario de foley en proceso de ejercitación para retiro, tiene orina colonizada,

asintomático por lo que no se indica ATB, se cambia sonda foley , en ejercitación para retiro, con síndrome nefrótico y falla renal secundaria a patologías de base, se difiere biopsia renal por orina colonizada y teniendo en cuenta las patologías del paciente no s ebeneficiaría de inmunosupresión por lo qye se decide seguimiento ambulatorio y evitra nefrotóxicos

PLAN DE MANEJO:

- Infeccioso: en tto con voriconazol por neumonia por aspergillus, sin requerimientos de O2, completar 56 días de tto, con Tac de tórax evolutivo mucho mejor

Por PNA I° por E. faecalis resistente a vancomicina tratado con linezolid por 19 días después ampicilina día 5, posteriormente UROCULTIVO KLEBSIELLA PNEUMONIAE (S) A ERTAPENEM completó trtamiento, ahora orina inflamatoria pero asintomático con PAE BLEE resistente a carbapenemicos. Se discurió con infecto y dado que se interpreta como bacteiuria asintomática se decide cambio de S Foley sin manejo ATB, mantener ejercitación para retiro de sonda foley.

- Reumatologico: Derivado de HSC ante sospecha de vasculitis ANCA por ANCAp (+), sin embargo con Anti MPO y PR3 (-), posee ANA + 1/80, panel de miositis con Anti Ro (+). reumnato escribe Sin vasculitis. Tiene miopatia con panel de miositis Ro 52 15, PL-12: 12 (positivos de 11-50. >50 positvo fuerte), Sospecha de miopatia por VIH, solicito CK (N), pruebas tiroideas, HMGCR, seguimiento por reumatología por CAE:
- Renal: Sd nefrótico impuro. Candidato a BR pero diferida por proceso infeccioso activo. Se ha avanzado en resto del estudio con VHB/VHC/EFP e IF en sangre todo pendiente, no disponible en sistema. IgG 2004 IgA 571 IgM 73.3. Tiene crea en aumento con BUN/crea 15, TAC TAP informa componente congestivo, se asocio furosemida el dia 10/12. orina colonizada, se decide no biopsia renal seguimiento por nefrología al alta
- Cardiaco: mantener DAPG ante IAM < 1 año. Por el mmento sin estatinas ante miopatía en estudio.
- PLAN DE ALTA: traslado a hospital de san carlos para continuar con rehabilitación en casa, se dejará seguimiento por nefrología, reumato y tiene que rescatar seguimiento por inmunología. al alta.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo: reltivo / PLPP / contención físico SOS
2. Régimen: liviano hiposodico para diabetico, restricción de líquidos a menos de 1 litro al día
3. - Voriconazol 200 mg c/12 hrs VO (42/56)
4. - Triumeq 1 comp día VO
5. - Entecavir 0.5 mg c/48 hrs
6. - Clonazepam 2 mg noche VO
7. - Quetiapina 25 mg día VO
8. - Paracetamol 1 g VO SOS
9. - Bicarbonato de sodio 1 gr cada 8 hrs VO
10. - Pregabalina 75 mg c/24 hrs VO
11. - Aspirina 100 mg día VO
12. - Clopidogrel 75 mg día VO
13. - losartan 50mg/dia
14. - KNT R y M
15. - ejercicios para retiro de sonda foley
16. HEPARINA 1 CC C/12 HRS S/C
17. FUROSEMIDA 40MG C/12H VO
18. NPH 16UDS AM
19. PENDIENTE RESULTADO de EFP + inmunofijación en suero (10/12) INMUNOFIJACIÓN EN ORINA (11/12) relacion de cadenas livianas.
20. SEGUIMIENTO POR NEFROLOGÍA y POR REUMATO
21. AL ALTA EFECTIVA COMUNICARSE AL 426505 PARA CONTINUIDAD DE CONTROLES DEL POLI DE INMUNOLOGÍA
22. TRASLADO A HSC PARA CONTINUAR CON REHABIILITACIÓN DOMICILIARIA, AYUDAS TÉCNICAS

JENNIE SALGADO LOPEZ
MEDICO TRATANTE
26707190-K

Salgado López
Nefróloga
26.707.190-K